KIT 7 – CRISE CONVULSIVA / ESTADO DE MAL EPILÉPTICO

Referências: ABRAMEDE 2024 • LBE 2023 • AHA/ACLS 2020 • SBN • Ministério da Saúde

---

Objetivo

Padronizar a solicitação de exames laboratoriais e de imagem nos casos de crise convulsiva aguda ou estado de mal epiléptico (EME), garantindo investigação rápida das causas desencadeantes e o uso racional dos exames no pronto-socorro.

---

1. AVALIAÇÃO INICIAL – ABORDAGEM CLÍNICA

- Identificar **tempo e tipo da crise** (tônico-clônica, focal, ausência, mioclônica, atônica).
- Avaliar **nível de consciência pós-ictal**, tempo de recuperação e recorrência.
- Procurar **causa secundária:** trauma, infecção, hipoglicemia, distúrbio hidroeletrolítico, intoxicação ou suspensão de anticonvulsivante.
- Em **crise ativa > 5 minutos**, iniciar **protocolo de EME** e estabilizar ABC.
- Após estabilização, seguir com exames conforme quadro clínico.

---

2. EXAMES LABORATORIAIS

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
Glicemia capilar imediata	Obrigatório em toda crise convulsiva.	—
Gasometria arterial / venosa	Avaliar acidose láctica pós-crise, hipóxia, hipercapnia.	Após crise isolada curta com recuperação plena.
Eletrólitos (Na, K, Ca, Mg)	Toda crise nova, EME ou refratária; avaliação de distúrbios metabólicos.	Casos epilépticos conhecidos, compensados e estáveis.
Ureia / Creatinina / Osmolaridade	Avaliar função renal, intoxicação por lítio, uremia, distúrbios metabólicos.	Crise isolada leve, sem comorbidades.
TGO / TGP / Bilirrubinas	Suspeita de hepatopatia, intoxicação, insuficiência hepática.	Casos com causa metabólica ou traumática conhecida.
Hemograma completo	Suspeita de infecção sistêmica, sepse, meningite, encefalite.	Paciente com epilepsia conhecida e recuperação habitual.

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
PCR / Procalcitonina	Crises associadas a febre, sepse, infecção SNC.	Crise isolada, sem febre.
Cálcio iônico / Magnésio sérico	Convulsões refratárias, gestantes, uso de diuréticos, etilismo.	Casos simples com recuperação rápida.
Beta-hCG	Toda mulher em idade fértil.	—

3. EXAMES DE IMAGEM

a) Primeira linha

Exame	Indicação	Evitar / Não Indicado
TC de Crânio sem contraste	Primeira escolha em crises **focais, prolongadas, com trauma, déficit focal, febre, uso de anticoagulante ou primeira crise**.	Crise epiléptica típica, paciente conhecido, sem sinais novos.
RX de Tórax	Paciente pós-crise com queda, trauma torácico ou suspeita de aspiração.	Crise leve sem repercussão respiratória.
ECG 12 derivações	Avaliar arritmias, alterações QT ou distúrbios eletrolíticos associados.	—

4. PRINCIPAIS ETIOLOGIAS E EXAMES CORRESPONDENTES

Causa Suspeita	Exames Laboratoriais	Imagem Indicada
Epilepsia idiopática (crise habitual)	Nenhum adicional, monitorar anticonvulsivante	Nenhuma ou TC se alteração clínica
Primeira crise na vida	Glicemia, eletrólitos, função renal, toxicológico, beta-hCG	TC crânio ± RM
Crise focal / prolongada / com déficit	Gasometria, eletrólitos, função hepática	TC crânio ± RM
Crise febril / séptica	Hemograma, PCR, culturas	TC crânio ± PL
Crise metabólica (CAD, hipoNa, hipoCa, hepática, urêmica)	Gasometria, eletrólitos, função renal/hepática	—
Crise por intoxicação / abstinência	Toxicológico, alcoolemia, eletrólitos	TC crânio se trauma associado

5. PRIORIDADES

- **Controlar a crise primeiro** (benzodiazepínico EV → anticonvulsivante de manutenção).
- **Realizar glicemia capilar imediata.**

- **Evitar atrasar TC de crânio** em primeira crise, déficit focal ou uso de anticoagulantes.
- **Não solicitar exames extensos de rotina** em crises típicas, autolimitadas e já diagnosticadas.
- **Considerar causas metabólicas e tóxicas** como mais prevalentes em adultos e idosos.
- **Punção lombar** deve ser feita apenas após exclusão de hipertensão intracraniana.

Resumo Prático:

Cenário Clínico	Exames Laboratoriais	Exames de Imagem
Crise única em epiléptico conhecido	Nenhum adicional	—
Primeira crise	Glicemia, eletrólitos, função renal/hepática, toxicológico, beta-hCG	TC crânio ± RM
Crise com trauma / déficit focal / anticoagulado	Hemograma, coagulograma, eletrólitos	TC crânio sem contraste
Crise febril / infecciosa	Hemograma, PCR, culturas, eletrólitos	TC crânio ± PL
Crise metabólica / tóxica	Gasometria, eletrólitos, toxicológico	—
Estado de mal epiléptico (EME)	Gasometria, eletrólitos, função renal, lactato, anticonvulsivante sérico	TC crânio ± EEG

Conclusão

A abordagem diagnóstica das crises convulsivas deve ser direcionada à **identificação da causa precipitante** e **prevenção de recidivas**. O uso racional de exames evita atrasos no tratamento e reduz custos, sem comprometer a segurança do paciente.

✅ Diagnóstico rápido e seguro
✅ Correção de causas reversíveis
✅ Redução de exames desnecessários
✅ Fluxo otimizado no pronto-socorro